



**MAJOR
ECN**

FICHES DE RÉVISION

CARDIOLOGIE

Hypertension Artérielle

Année 2025-2026

ITEM 224

Item 224

Plan du cours

Cardiologie · Hypertension Artérielle

I Définition et épidémiologie

Cadre nosologique de l'HTA et poids de santé publique.

- A. Définitions et seuils** — Seuils tensionnels et grades.
- B. Épidémiologie** — Prévalence et facteurs de risque.

II Diagnostic et bilan initial

Confirmation diagnostique et recherche du retentissement.

- A. Mesure de la pression artérielle** — Conditions de mesure et MAPA.
- B. Bilan de retentissement** — Atteinte des organes cibles.

III Prise en charge thérapeutique

Mesures hygiéno-diététiques et traitement médicamenteux.

- A. Mesures non médicamenteuses** — Règles hygiéno-diététiques.
- B. Traitement médicamenteux** — Classes et stratégie d'association.

I | Définition et épidémiologie

A Définitions et seuils

- **Hypertension artérielle (HTA)** : pression artérielle systolique (**PAS**) $\geq$ **140 mmHg** et/ou pression artérielle diastolique (**PAD**) $\geq$ **90 mmHg** au cabinet.
 - Mesure confirmée à **deux consultations** distinctes.
 - Seuils abaissés en automesure : $\geq$ **135/85 mmHg**.
- **Grades de sévérité** :
 - **Grade 1** : 140-159 / 90-99 mmHg.
 - **Grade 2** : 160-179 / 100-109 mmHg.
 - **Grade 3** : $\geq$ 180 / 110 mmHg.
- **HTA blouse blanche** : élévation tensionnelle limitée au cabinet médical, à confirmer par **MAPA** ou **automesure**.

B Épidémiologie

- **Prévalence** : environ **30 %** de la population adulte ; augmente avec l'âge.
- Premier motif de consultation en médecine générale.
- **Facteurs de risque** :
 - Non modifiables : **âge**, **sexe masculin**, hérédité.
 - Modifiables : **surpoids**, **sédentarité**, **consommation de sel**, **alcool**, tabac.
- L'HTA est un facteur de risque **cardiovasculaire majeur** : AVC, insuffisance cardiaque, coronaropathie, néphropathie.

🎯 À retenir

Le diagnostic d'HTA repose sur des mesures **répétées** et **standardisées**. Une seule mesure élevée ne suffit jamais.

⚠️ Piège ECN

Ne pas confondre **HTA blouse blanche** (PA élevée au cabinet uniquement) et **HTA masquée** (PA normale au cabinet, élevée en ambulatoire) — pronostic différent.

II | Diagnostic et bilan initial

A Mesure de la pression artérielle

- **Conditions de mesure :**

- Patient au **repos** depuis 5 minutes, assis.
- Brassard adapté à la circonférence du bras.
- Mesure aux **deux bras** lors du bilan initial.

- **MAPA** (mesure ambulatoire sur 24 h) : référence pour confirmer le diagnostic et dépister l'**HTA masquée**.

- **Automesure** : 3 mesures matin et soir, 3 jours de suite (**règle des 3**).

B Bilan de retentissement

- Recherche d'une **atteinte des organes cibles** :

- **Cœur** : ECG, hypertrophie ventriculaire gauche.
- **Rein** : créatininémie, **DFG**, protéinurie.
- **Œil** : rétinopathie hypertensive si HTA sévère.

- **Bilan biologique minimal** : kaliémie, glycémie à jeun, bilan lipidique, créatininémie.

- Recherche d'une **HTA secondaire** si HTA résistante, sujet jeune ou signes d'orientation.



Mots-clés tombés

- MAPA
- Hypertrophie ventriculaire gauche
- Organes cibles
- HTA secondaire
- Protéinurie

III | Prise en charge thérapeutique

A Mesures non médicamenteuses

- **Règles hygiéno-diététiques**, systématiques :
 - Réduction des apports en **sel** (< 6 g/j).
 - Perte de poids en cas de surpoids.
 - **Activité physique** régulière (30 min/j).
 - Limitation de l'**alcool**, arrêt du **tabac**.
- Toujours associées au traitement médicamenteux.

B Traitement médicamenteux

- **Cinq classes** de première intention :
 - **IEC** et **ARA II** : bloqueurs du système rénine-angiotensine.
 - **Inhibiteurs calciques**.
 - **Diurétiques thiazidiques**.
 - **Bêtabloquants** (indications spécifiques).
- Stratégie : **bithérapie d'emblée** souvent recommandée, en privilégiant les **associations fixes**.
- Objectif tensionnel : **< 140/90 mmHg**, voire **< 130/80 mmHg** si bien toléré.



Astuce mnémotechnique

Les 5 classes — moyen mnémotechnique « **A-B-C-D** » : **A**RA II / IEC, **B**êtabloquants, **C**alciques, **D**iurétiques.

Synthèse — Tableaux de révision

Grades de sévérité de l'HTA

Grade	PAS (mmHg)	PAD (mmHg)
Grade 1	140-159	90-99
Grade 2	160-179	100-109
Grade 3	≥ 180	≥ 110

Classes thérapeutiques de première intention

Classe	Exemple	Indication préférentielle
IEC	Ramipril	Diabète, insuffisance cardiaque
ARA II	Losartan	Intolérance aux IEC (toux)
Inhibiteur calcique	Amlodipine	Sujet âgé, sujet noir
Diurétique thiazidique	Hydrochlorothiazide	Sujet âgé
Bêtabloquant	Bisoprolol	Coronaropathie associée

L'ESSENTIEL

À retenir absolument

Hypertension Artérielle

- L'**HTA** est définie par une PA $\geq$ **140/90 mmHg** au cabinet, confirmée sur des mesures répétées.
- La **MAPA** et l'**automesure** confirment le diagnostic et dépistent l'HTA blouse blanche et l'HTA masquée.
- Le bilan initial recherche systématiquement une **atteinte des organes cibles** et une **HTA secondaire**.
- Les **règles hygiéno-diététiques** sont la base du traitement, toujours associées aux médicaments.
- Cinq classes de première intention ; la **bithérapie** est souvent instaurée d'emblée.
- L'objectif tensionnel est $<$ **140/90 mmHg**, idéalement $<$ **130/80 mmHg** si la tolérance le permet.



MAJOR ECN · 2025-2026